

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0283

Paginas del documento: 7

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

õem à dificuldade de lactação materna, fazendo com que esses bebês comecem o aleitamento mesmo pela imaturidade, que também corrobora para o atraso na amamentação⁴.

coorte prospectiva⁵, realizado com puérperas no pós-parto prematuro em uma maternidade de Alagoas (Brasil), constatou que, dos 132 binômios mãe-bebê estudados, 71,12% abandonaram o AM de forma precoce e apenas 28,8% tiveram AME até os seis meses de idade.

Além da prematuridade, outros fatores estão associados ao desmame precoce, como a baixa escolaridade materna e a falta de informação sobre o AM⁶. Ademais, a necessidade de voltar à rotina, o estresse e as jornadas de trabalho provocam alterações na fisiologia da lactação, diminuindo a produção de leite e, consequentemente, ao desmame.

Nesse contexto, é importante que os profissionais de saúde esclareçam as mães de RNPTs quanto aos seus direitos, garantidos nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e fundamentados na legislação brasileira para proteção da prática, por meio de ações de promoção e proteção do AM no pré-natal, no parto e no puerpério.

Estudo transversal realizado no Rio de Janeiro revelou que, das 429 mães de crianças menores de seis meses atendidas em unidades básicas de saúde, 78,8% referiram ter recebido orientações sobre amamentação no pré-natal; 93,9% tinham recebido pelo menos uma orientação sobre AM; 59,7% informaram não ter trabalho remunerado ou ser autônoma; e 40,3% (n=173) referiram ter vínculo empregatício. Dessas mães, 17,2% (n=74) informaram que já haviam retornado ao trabalho no momento da coleta de dados. Menos de um quarto das mulheres amamentando estavam de licença-maternidade durante a entrevista e estas tiveram um percentual 91% maior de AME em relação àquelas que não estavam de licença. Portanto, verificou-se que o fato de a mãe não ter sido orientada sobre o AM foi associado a menor prevalência do AME, e a mãe estar em licença-maternidade se associou a maior prevalência de AME⁷.

Diante destes apontamentos, surgiu o seguinte questionamento: Como as mães de RNPTs são orientadas sobre os seus direitos garantidos pela legislação, durante a internação do RNPT? Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar as orientações recebidas pelas mães de prematuros sobre direitos protetivos ao aleitamento materno.

Este estudo se justifica, pois a participação dos profissionais de saúde se mostra fundamental no sentido de informar e assegurar os direitos de proteção ao AM, a saber: amamentar durante a internação hospitalar; ter um acompanhante durante o processo de parturição; gozar de licença-maternidade e paternidade; assim como ter o emprego garantido, com as especificidades da jornada laboral para as mulheres trabalhadoras que amamentam^{8,9}.

REVISÃO DE LITERATURA

Dados de 28 países da África, América Latina, Caribe e Ásia verificou que ter uma legislação sobre a licença-maternidade e cumprir o Código Internacional de Marketing para Substitutos do Leite Materno da OMS são fundamentais para alcançar o ambiente de suporte necessário para que a promoção do AME tenha sucesso¹⁰.

Em relação à licença-maternidade, na União Europeia há uma diretriz para assegurar a licença-maternidade em que as mulheres tenham, no mínimo, 14 semanas de dispensa, das quais duas podem ser compulsórias e alocadas para antes e/ou depois do parto. Entretanto, esses países têm liberdade para decidir como aplicará a diretiva. Caso a licença seja remunerada, esta pode ser paga pela empresa, pelo governo ou por pagamento combinado¹⁰.

No Brasil, sabe-se que a legislação de proteção ao aleitamento materno é uma das mais avançadas, onde toda mulher com vínculo empregatício tem direito a ausência do trabalho por 120 dias para amamentar, sem que isso afete seu salário e sendo mantido seu emprego por até cinco meses após o parto. Outras iniciativas são estimuladas, como a alteração do tempo de licença-maternidade de 120 para 180 dias concedida por empresas que possuem o título de “Empresa Cidadã”, onde, além do benefício para a mulher e o recém-nascido, a empresa recebe incentivos fiscais¹¹.

Já na licença paternidade, são concedidos ao pai trabalhador com carteira assinada apenas cinco dias para se dedicar de forma exclusiva ao bebê. Isso pode ser um fator negativo para o desenvolvimento do vínculo pai-bebê. No caso de Empresas Cidadãs, há um prazo maior estabelecido, 15 dias⁸. No entanto, poucas empresas brasileiras se enquadram nos critérios estabelecidos para esse modelo. Pais de RNPTs se sentem impactados com o fato de estarem afastados dos bebês durante grande parte do tempo e, por isso, necessitam reorganizar a rotina diária entre trabalho e hospital para que consigam estar próximos do filho¹².

No contexto hospitalar, o direito de amamentar durante a internação encontra-se assegurado, sendo os estabelecimentos de saúde obrigados a acompanhar a prática da amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada⁸. Outro direito estabelecido por lei é a presença de um acompanhante durante o parto, como fonte de apoio para a mulher, que se encontra sob a influência de vários sentimentos, além de insegurança e medo. Estudo

pré-natal (18,4%), amigos e familiares (22,9%) e mídia (18,9%)¹³.

o ao trabalho, mulheres com contrato formal têm direito garantido a um local apropriado para cuidados durante o período em que elas estejam trabalhando¹⁴. A Constituição Federal de 1988 também assegura o direito à creche e pré-escola aos filhos das trabalhadoras desde o nascimento até os cinco anos de idade¹⁵. Encontra-se assegurado, ainda, o direito a pausas para amamentar durante a jornada de trabalho. São permitidas duas pausas de 30 minutos durante o expediente até que o bebê complete seis meses¹⁶. Isto é extremamente relevante, pois, além de manter o laço mãe-bebê, também contribui para a saúde mental da mulher, como revelado por um estudo que mostra que o impacto emocional gerado pelo afastamento, em decorrência da volta ao trabalho, pode agregar estresse, insegurança e culpa à rotina da mulher¹⁷.

Portanto, percebe-se que a legislação protetiva ao aleitamento materno tem que avançar em todos os países do mundo, especialmente no Brasil, onde só estão garantidos tais direitos trabalhistas para as mulheres com contrato formal de trabalho.

METODO

Estudo transversal e descritivo, realizado no período de agosto de 2017 a dezembro de 2018, na unidade neonatal de um hospital universitário Hospital Amigo da Criança (HAC) do Município do Rio de Janeiro. Considerando uma amostra não probabilística, a população do estudo foi composta por 31 as mães de RNPTs, que tiveram seus filhos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Os critérios de inclusão, foram: mãe estar acompanhando o RNPT durante a internação; tempo mínimo de internação do RNPT de 48 horas. Foram excluídas mães que não pariram na maternidade; não manifestaram desejo de amamentar; portadoras de vírus da imunodeficiência humana e/ou vírus T-linfotrófico humano 1; em uso de medicamentos que impedissem a amamentação; e que tiveram RNPTs portadores de galactosemia clássica / leucínose / fenilcetonúria.

A captação das participantes do estudo deu-se conforme a disponibilidade materna. Para a aproximação com as mães a pesquisadora e a auxiliar de pesquisa realizavam visitas em diferentes horários na UTIN e no alojamento materno, quando a unidade fornecia, a fim de convidá-las a participar da pesquisa. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual, com apoio de um formulário, dividido em duas partes: a primeira, contendo dezenove perguntas fechadas sobre características sociodemográficas e obstétricas; a segunda, com oito perguntas abertas e fechadas que versavam sobre os direitos para proteger a prática do AM garantidos pela legislação.

Cabe ressaltar que antes de cada pergunta da segunda parte do instrumento, a pesquisadora esclarecia sobre o direito em questão, a fim de assegurar que as participantes sabiam do que se tratava. Ademais, quando a mulher afirmava ter recebido orientações acerca de um direito específico, questionava-se o momento em que essa orientação havia sido fornecida e por qual profissional de saúde. As entrevistas duraram em média 15 minutos, foram realizadas por uma pesquisadora e/ou uma auxiliar de pesquisa, em sala privativa no alojamento materno. Não houve perdas ou recusas no processo de coleta dos dados.

Salienta-se que, para verificar a adequação do instrumento de coleta de dados quanto à clareza e conteúdo, foi realizado teste-piloto com oito mulheres, não incluídas na amostragem final do estudo. Não foram necessárias adequações no instrumento de coleta de dados. Os dados coletados foram inseridos em planilhas do programa Microsoft Excel®, versão 2010, e analisados pela estatística descritiva simples por meio de frequências absoluta e relativa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente e pela coparticipante. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou Termo de Assentimento.

RESULTADOS

Participaram do estudo 31 mães de RNPTs, com média de idade de 29,77 anos, sendo a mínima de 18 e a máxima de 43 anos. Das entrevistadas, 45,16% (n=14) declararam-se solteiras; 35,48% (n=11), casadas; 12,90% (n=4), em união estável; e 3,23%, viúvas (n=1); 61,29% (n=19) possuíam um emprego e 78,95% (n=15) possuíam carteira assinada.

Sobre os dados gestacionais, 93,55% (n=29) das mulheres realizaram o pré-natal, e 68,97% (n=20) tiveram 6 ou mais consultas. Das 31 entrevistadas, 77,42% (n=24) receberam alguma orientação pelos profissionais e 22,58% (n=7) não foram orientadas sobre nenhum dos direitos protetivos do AM.

A Tabela 1 descreve o percentual de mães de RNPTs que receberam orientações dos profissionais de saúde e quais foram os direitos relativos à proteção do AM foram abordados.

	Orientações recebidas (n=31)	
	Sim (n%)	Não (n%)
Recebimento de alguma orientação pelos profissionais de saúde sobre os direitos gravídico-puerperais	24 (77,42)	7 (22,58)
Direito da criança de ser amamentada durante a internação	20 (64,52)	11 (35,48)
Direito da gestante de ter um acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto	24 (77,42)	7 (22,58)
Licença-maternidade	14 (45,16)	17 (54,84)
Licença-paternidade	11 (35,48)	20 (64,52)
Direito à garantia de emprego	8 (25,81)	23 (74,19)
Direito à creche	2 (6,45)	29 (93,55)
Pausas para amamentar durante o trabalho	6 (19,35)	25 (80,65)

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Das 24 mães que receberam algum tipo de orientação, 66,67% (n=16) relataram terem sido orientadas durante pré-natal, 45,83% (n=11), durante sua internação no alojamento e 4,17% (n=1), durante a internação do bebê na unidade neonatal.

Em relação aos profissionais que realizaram a orientação, das 24 mães orientadas, 29,17% (n=7) relataram que foram orientadas por assistentes sociais; 29,17% (n=7), por médicos; 54,17% (n=13), por enfermeiros; 8,34% (n=2), por profissionais do Banco de Leite Humano; 4,17% (n=1), por psicólogos; e 12,50% (n=3) não souberam informar a categoria profissional que as orientou.

DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo mostraram que a maioria das mães (77,42%) recebeu alguma orientação pelos profissionais de saúde acerca dos direitos protetivos do AM. No entanto, no que se refere às orientações sobre os direitos trabalhistas, a maioria das participantes referiu não ter sido orientada em relação ao direito da licença-maternidade (54,85%), licença-paternidade (64,62%), garantia de emprego (74,19%), auxílio-creche (93,55%) e pausa para amamentar durante a jornada de trabalho (80,65%).

Estudo quantitativo realizado em Londrina (Brasil) mostrou que 21 (58,3%) das 36 entrevistadas receberam orientações de profissionais quanto à importância do AME durante o pré-natal, sendo que estas ações tiveram um efeito positivo sobre o comportamento das mulheres participantes, pois a prevalência do AME aos 6 meses foi além do preconizado pela OMS¹⁸.

Outro estudo, realizado em Florianópolis (Brasil), verificou que, apesar de todos os profissionais de saúde informarem sobre a amamentação no pré-natal, muitas gestantes indicaram não sentir segurança quanto ao entendimento de algumas informações, em contrapartida, e outras disseram não ter recebido qualquer informação durante as consultas de pré-natal¹².

Outros estudos mostram que a maioria das orientações sobre as questões de amamentação foi realizada durante as consultas de pré-natal, puerpério e consultas de *follow up* nas unidades de saúde. Assim, tais dados mostram a necessidade que essas orientações sejam fornecidas também durante a internação^{12,19}.

Em relação à categoria profissional que orientou as mães de RNPTs, no presente estudo, observa-se que a maioria (54,17%) das orientações foi dada por enfermeiros. O mesmo padrão de resultados é apresentado em outras investigações^{18,20}. Estudo descritivo que analisou as orientações sobre amamentação dadas por profissionais, mostrou que 50% das orientações foram realizadas por enfermeiros do pré-natal na atenção básica e que, na ocasião da internação na maternidade, 87,6% foram orientadas por profissionais desta categoria¹⁸.

Sobre o direito de ter acompanhante, no presente estudo, 77,42% das mães receberam informações, resultados diferentes à pesquisa realizada em Sergipe (Brasil)²¹, que evidenciou que apenas 35% das mulheres entrevistadas foram

er ser informada sobre esse direito durante o pré-natal e ter essa informação reforçada pelos durante permanência na maternidade e após a alta, nas unidades básicas de saúde.

se o papel fundamental do *advocacy* em saúde que a equipe de enfermagem pode exercer, orientando-as e fazendo com que seus direitos sejam garantidos²², como por exemplo, o direito de ter um acompanhante durante o trabalho de parto, hoje já bastante difundido, pois aumenta a confiança no processo de parir, visto que, mesmo assistida por vários profissionais de saúde, as mulheres podem se sentir sozinhas por não estarem no seu contexto familiar e social¹².

A entrada da mulher no mercado de trabalho acarretou muitas mudanças na conformação da sociedade, inclusive, no modo pensar da mulher atual. Nesse contexto, as leis trabalhistas foram estendidas às mulheres trabalhadoras no Brasil a partir de 1935, baseando-se na Convenção da Organização Internacional do Trabalho em 1919. O Decreto-Lei nº 5452/1943, que trata da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), garante proteção à maternidade²³.

Para que os direitos das mulheres sejam garantidos, é necessário que as mesmas sejam informadas sobre como e quando esses direitos devem ser aplicados durante o processo gravídico-puerperal, a fim de que estejam instrumentalizadas para sua efetivação. Estudo transversal²¹ mostrou que 55% das gestantes entrevistadas não tinham conhecimento do direito à licença-maternidade, que é garantido a todas as trabalhadoras formais. Resultado semelhante foi encontrado no presente estudo, onde 54,84% responderam não terem sido informadas sobre a licença-maternidade.

Cabe ressaltar que, no mês de março de 2020, foi aprovada, em caráter liminar, pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, a prorrogação do início da licença-maternidade para mães que tenham seus bebês internados por mais de 3 dias, fazendo com que o direito passe a ser contado a partir da alta hospitalar. Ressalta-se que existe uma proposta de emenda constitucional que se encontra em tramitação desde 2015 para que haja a inserção do direito à ampliação da licença-maternidade no caso de bebês prematuros na Constituição Federal^{24,25}. Portanto, se faz necessário que os profissionais de saúde conheçam a decisão liminar e passem a orientar as mães durante o pré-natal e na hospitalização.

Quando se trata da figura paterna, os desafios são ainda maiores, tendo em vista a carência de legislações que assegurem o acompanhamento do RNPT pelo pai, o que pode contribuir para um distanciamento entre pai, mãe e bebê. Pesquisa qualitativa realizada em uma UTIN no Paraná (Brasil) mostrou que os pais-homens defrontam-se com inúmeros desafios para acompanharem seus filhos durante a internação. Muitos referem não ter flexibilidade no trabalho, retornando em 5 dias, ou que sequer possuem o direito à licença-paternidade²⁶.

Estudo transversal²¹ mostrou que 51% das gestantes entrevistadas não sabiam da existência do direito à licença-paternidade, informação que pode ser comparada com este estudo, onde 64,62% das participantes não sabiam deste direito. A importância do pai nesse momento tem sido percebida pela equipe multiprofissional como algo positivo, pois, além de estreitar laços com a companheira, também é importante para fortalecer o vínculo com o recém-nascido²⁶. Portanto, é fundamental que durante o pré-natal o pai compareça às consultas e que a equipe de saúde informe e esclareça dúvidas sobre os direitos. A promoção e apoio aos pais em relação aos seus direitos também devem ser fornecidas durante a internação do seu filho nas unidades neonatais.

O período pós-parto é repleto de mudanças e adaptações na vida dos pais, que se somam às preocupações e incertezas sobre o estado de saúde de seu filho. Nesse contexto, torna-se fundamental que o direito à garantia de trabalho seja assegurado.

No presente estudo, quando as mulheres foram perguntadas sobre o direito de não serem demitidas, somente 25,81% responderam ter conhecimento sobre a garantia de emprego. Apesar de ser um percentual baixo, ainda foi um pouco maior do que o encontrado em um estudo transversal realizado em Goiânia, onde apenas 19% das entrevistadas tinham conhecimento sobre esse direito²¹.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é garantido, onde trabalham 30 mulheres ou mais acima de 16 anos de idade, o direito de ter um local apropriado onde elas possam ter sob cuidado e assistência seus filhos durante o período de amamentação. Quando isso não for possível na própria empresa, deve ser feito através de convênio ou diretamente, para que o direito se aplique, em instituições como o Sesi, Sesc, LBA ou entidades sindicais²³.

Apesar do tema amamentação ser bastante estudado, são poucos os estudos encontrados que abordam a respeito da orientação às gestantes e mulheres sobre o direito à garantia da creche. Estudo²⁷ com o objetivo de investigar a luta de mulheres operárias pela educação de seus filhos em creches verificou se o usufruto desse direito mostrava em seus resultados relatos de mães que desejavam usufruir de tal direito. O presente estudo mostra que quase a totalidade das mulheres não foram orientadas sobre o direito, o que pode levar ao não usufruto deste.

jornada de trabalho. Estudos nacionais^{21,28} encontraram resultados semelhantes, evidenciando em lei esse direito, a maioria das mulheres o desconhece por falta de informações. Nesse sentido, o papel dos profissionais envolvidos com o AM. Parece haver uma fragmentação em nossas unhas a um custo alto para os RNPTs e famílias.

Limitações do estudo

As limitações do estudo foram relacionadas ao uso da amostragem não probabilística e à coleta ter sido realizada em apenas uma unidade neonatal, dificultando a generalização dos resultados encontrados. Destaca-se o viés de memória em relação aos dados coletados quanto à categoria profissional que realizou a orientação. As mães podem não lembrar ou saber com precisão a categoria profissional que as orientou.

CONCLUSÃO

Conclui-se que menos da metade das mães de recém-nascidos prematuros entrevistadas havia sido orientadas em relação aos direitos de licença-maternidade, paternidade, garantia de emprego e direito à creche. O direito protetivo mais abordado pelos profissionais de saúde foi o da gestante ter um acompanhante durante o trabalho de parto, parto e puerpério

Dentre os profissionais que realizavam as orientações para as mães sobre os direitos protetivos garantidos pela legislação brasileira sobre AM, destaca-se a equipe de enfermagem como a categoria que mais se fez presente no esclarecimento de dúvidas e cuidados próximos às famílias. Médicos, assistentes sociais, psicólogos e profissionais do banco de leite humano também forneceram orientação, porém em número reduzido.

Assim, aponta-se a necessidade de fortalecer a tríade promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno do RNPT, através de ações de educação permanente que capacitem os profissionais da equipe interdisciplinar, para o desenvolvimento de estratégias de divulgação dos direitos protetivos da mulher e da criança.

REFERÊNCIAS

1. Patel AL, Kim JH. Human milk and necrotizing enterocolitis. *Semin Pediatr Surg.* [Internet]. 2018 [cited 2021 Dec 09]; 27(1):34-

